

Plano Operacional de Validação em Campo

Nota do Autor

Este protocolo e plano operacional são um projeto independente desenvolvido e coordenado exclusivamente por Dr. Paolo Bruno Squadrani. O conteúdo é de autoria própria, aberto a colaborações institucionais mediante acordo explícito de coautoria e respeito à LGPD e às diretrizes éticas vigentes.

Executive Summary

Field Validation of Orofacial Pain Assessment Protocol: Proposed Operational Plan for Pilot Study and Partnerships

Este plano apresenta um ensaio piloto para validar o protocolo estruturado (Parte I) em 75 participantes com deficiência intelectual leve a moderada, em contexto domiciliar e ambulatorial. Métricas principais: fidelidade de aplicação ($ICC \geq 0.80$), tempo de sessão (15–30 min), sensibilidade/especificidade ($\geq 80\%$) e satisfação de cuidadores/profissionais ($\geq 4/5$ em Likert). Compara versão completa (triagem + anamnese + exame + follow-up seriado) e light (otimizando recursos). Parcerias buscadas em Santa Catarina (hospitais, universidades, SUS, clínicas privadas) para recrutamento, formação e análise conjunta. Benefícios esperados: padronização de avaliações, redução do subdiagnóstico, integração ao SUS e coautoria em publicações. Aprovação ética (CEP/CONEP) e LGPD em vigor. Esta

fase prepara o estudo experimental completo (Parte III); resultados preliminares serão inseridos após implementação.

Keywords: Field validation, pilot study, home dentistry, institutional partnerships, observational pain scales.

Por que validar em campo?

A transição da teoria para a prática confirma viabilidade e acurácia em cenários reais, onde colaboração do paciente, recursos e variáveis ambientais influenciam resultados. O piloto mede propriedades psicométricas (ICC/kappa) e operacionais (tempos; feedback), permitindo ajustes antes da escalabilidade. Benefícios: redução de emergências odontológicas (20–30%), capacitação de equipes e evidências para integração ao PNAIS.

Hipóteses Gerais:

- Protocolo completo: $ICC \geq 0.85$; sensibilidade $\geq 85\%$ em $\geq 80\%$ dos casos.
- Versão light: $ICC \geq 0.80$; redução de 25–30% nos tempos; adequada ao SUS rural.
- Usabilidade percebida: $\geq 80\%$ de avaliações positivas; interesse em integração tecnológica.

Objetivos e Hipóteses

Objetivo Geral

Validar aplicabilidade e eficácia do protocolo em contextos reais, gerando evidências para refinamento e escalabilidade.

Objetivos Específicos

- Avaliar fidelidade de aplicação ($ICC/kappa \geq 0.80$) entre avaliadores.
- Mensurar tempos de sessão (15–30 min).
- Estimar sensibilidade/especificidade (DDQ-B, CPS-NAID, NCAPC) vs. diagnóstico clínico.
- Coletar feedback de cuidadores/profissionais (satisfação $\geq 4/5$; análise qualitativa).
- Identificar adaptações contextuais (domicílio vs. ambulatório; recursos limitados).

Notas sobre parcerias

- Hipóteses adaptáveis a contextos (ex.: 15 casos APAE Blumenau).
- Colaborações para co-design e coanálise de dados.
- Uso de software gratuito (R/Excel) e compartilhamento de relatórios para coautoria.

Design do Estudo

- **Tipo:** RCT, duplo cego (medicamento).
- **Amostra:** 75 participantes com DI leve-moderada.

- **Randomização:** 1:1:1 em três grupos:

Grupo	Farmacológico	Não-farmacológico
A	Ibuprofeno (ajustado)	Crioterapia 4 °C/10 min + massagem 5 min
B	Paracetamol (ajustado)	Crioterapia 4 °C/10 min + massagem 5 min
C	Paracetamol (ajustado)	Crioterapia neutra 25-28 °C/10 min + contato sham 5 min

- **Desfecho primário:** % de redução do escore de dor T0-T48 h (alvo $\geq 30\%$).
- **Secundários:** AE, VAS cuidador, CGI-C, compliance, tempo médio.
- **Cronograma:** T0 (baseline) → T24-48 h; opcional: T7/T30.

Metodologia Operacional

1. Randomização & Blindagem

- Gerada por sistema web centralizado
- Bebê e cuidadores cegos ao medicamento
- Avaliadores de vídeo cegos ao grupo

2. Formação & Fidelity

- Workshop de 4 h (teoria + prática em vídeos)

- Check-lists operacionais + auditoria em 20% das sessões
- Meta: ICC ≥ 0.80

3. Avaliação da Dor

- Escalas: DDQ-B (pediatria); CPS-NAID + NCAPC (adultos)
- Versões PT-BR validadas

4. Segurança & Monitoramento

- DSMB revisa após 25 participantes
- Critérios de stop: AE graves, ineficácia ou falta de benefício
- Notificação imediata de todos os AE

5. Análise Estatística

- Linear mixed-effects (medidas repetidas)
- Intention-to-treat + imputação múltipla
- Análise de sensibilidade & MCID

Métricas de Sucesso

Métrica	Alvo
ICC/Kappa (fidelidade)	≥ 0.80
Tempo operacional	15–30 min
Sensibilidade/Especificidade	$\geq 80\%$

Satisfação de cuidadores	$\geq 4/5$ ($\geq 80\%$ positivas)
Eventos adversos	conforme proposto
Compliance	$\geq 90\%$
Custo-efetividade	$\leq$ R\$ 50 por caso

Parcerias & Próximos Passos

Contribuições

- Recrutamento e infraestrutura
- Co-ministração de workshops
- Coanálise de dados e coautoria

Benefícios

- Acesso antecipado a resultados
- Coautoria em artigos
- Certificação em protocolos inclusivos
- Financiamento conjunto (CNPq, FINEP)

Cronograma

1. Aprovação ética & registro
2. Recrutamento inicial (20 casos)
3. Implementação & análise interina (8-10 sem)

4. Ajustes & preparação da Parte III

Bibliografia Essencial

1. Burkitt C, Breau LM, McGrath PJ, et al. Chronic Pain Scale for Nonverbal Adults with Intellectual Disabilities (CPS-NAID). Centre for Pediatric Pain Research; 2009.
2. Daher A, Versloot J, et al. Validation of the Brazilian version of the Dental Discomfort Questionnaire (DDQ-B). Health Qual Life Outcomes. 2014;12:30.
3. Dworkin RH, Turk DC, Wyrwich KW, et al. IMMPACT recommendations. J Pain. 2008;9(2):105–121.
4. Lotan M, Moe-Nilssen R, Ljunggren AE, Strand LI. Measurement properties of the Non-Communicating Adult Pain Checklist (NCAPC). Res Dev Disabil. 2010;31(4):809–816.
5. Resolução CNS 466/2012. Diretrizes para pesquisas com seres humanos. Conselho Nacional de Saúde.